

PERIMENOPAUSE RAGE

A raiva que ninguém te explicou.

Como as tuas hormonas estão a alterar a tua química cerebral, e o que podes fazer hoje.

PARA
MULHERES 38-50

LEITURA
7 MINUTOS

EDIÇÃO
2026 · 01

Catarina Veiga

MEDICINA FUNCIONAL · SAÚDE HORMONAL

CATARINAVEIGA.COM

A raiva da perimenopausa não é mau feitio. É química. E tem padrão.

01 · IDENTIFICAÇÃO

Reconheces este padrão?

Estes são os sinais mais comuns que aparecem entre os 38 e os 50 anos, muitas vezes anos antes de qualquer alteração visível no ciclo menstrual.

- | | |
|--|--|
| ☐ Acordas zangada sem razão aparente | ☐ Pequenas coisas disparam reações desproporcionais |
| ☐ Sentes-te "fora de ti", como se não fosses tu | ☐ Ansiedade nova, especialmente à tarde / noite |
| ☐ Piora claramente antes do período | ☐ Choros intensos seguidos de calma súbita |
| ☐ Sono mais fragmentado, acordas às 3-4h | ☐ Tolerância ao stress muito reduzida |
| ☐ Brain fog combinado com irritabilidade | ☐ Resposta exagerada a barulho, luz, multidões |

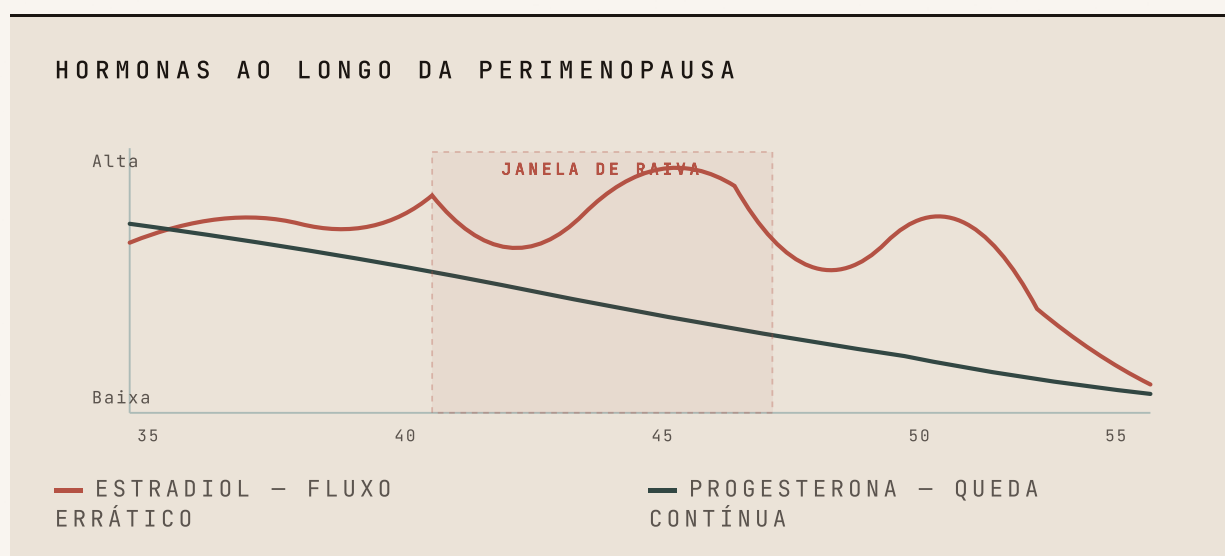
*Se reconheces 4 ou mais destes sinais, provavelmente não é depressão.
É a tua biologia em transição.*

A perimenopausa começa, em média, 7 a 10 anos antes da menopausa. Mas a maioria das mulheres não sabe que já está nela.

02 · MECANISMO

O que está a acontecer.

Durante a perimenopausa não há uma queda linear de hormonas. Há **caos**. O estradiol sobe e cai erráticamente. A progesterona cai primeiro e mais cedo do que se pensa, muitas vezes a partir dos 35 anos.



Estas duas curvas, juntas, criam a **janela de raiva**: o período em que o estradiol sobe e cai, mas a progesterona já não compensa. A química do cérebro perde a sua estabilizadora natural.

A maioria dos protocolos foca o estradiol. A pista mais subestimada é a progesterona.

03 · A PISTA DA PROGESTERONA

O Valium natural que paraste de produzir.

Quando a progesterona é metabolizada, transforma-se em alopregnanolona, um neurosteróide que se liga aos receptores GABA-A do cérebro. É exatamente o mesmo sistema que medicamentos como Valium ou Xanax ativam.

01 · ANTES

Progesterona → Alopregnanolona → Recetor GABA-A → Calma · sono · regulação emocional

02 · PERIMENOPAUSA

Progesterona em queda → Menos alopregnanolona → Tom GABA reduzido → Sistema nervoso em alerta

03 · RESULTADO

A amígdala dispara mais facilmente. O córtex pré-frontal regula com mais dificuldade. Coisas pequenas tornam-se gatilhos. Não é falta de auto-controlo. É falta de freio neuroquímico.

Esta é a razão pela qual a raiva da perimenopausa *parece vir do nada*. O sistema que te mantinha calma sem esforço deixou de existir na mesma intensidade. O que antes não te incomodava, agora dispara.

A boa notícia: o terreno responde. Quando se trabalha sono, açúcar, magnésio e estabilidade do ciclo, a química regula-se.

Sete ações com impacto rápido. Não substituem avaliação clínica, mas começam a estabilizar o sistema.

04 · O QUE PODE AJUDAR

Sete ações para começar hoje.

-
- | | |
|-------|---|
| 01 | Estabiliza o açúcar no sangue.
Pequeno-almoço com 25-30g de proteína + gordura nos primeiros 60 min. Nunca em jejum prolongado nos dias intensos.
Reduz picos de cortisol e adrenalina que amplificam a reatividade. |
| <hr/> | |
| 02 | Magnésio bisglicinato à noite.
300-400 mg, 30 min antes de dormir. Cofator de GABA, melhora sono e tolerância ao stress.
Confirma com profissional se tomas medicação. |
| <hr/> | |
| 03 | Luz natural nos primeiros 30-60 min depois de acordar.
5-15 min lá fora, sem óculos de sol. Acerta cortisol e melatonina, reduz fadiga vespertina.
Se não consegues sair, abre tudo: janela, luzes fortes. |
| <hr/> | |
| 04 | Treino de força 2-3× por semana.
Constrói músculo e regula cortisol melhor que cardio prolongado em perimenopausa.
Mesmo 20-30 min com pesos em casa conta. |
| <hr/> | |
| 05 | Tracking simples do ciclo + dos dias de raiva.
Anota numa app ou caderno: o padrão revela-se em 2-3 ciclos. A maioria vê piora na fase lútea.
Saber o padrão diminui o pânico de não-controlo. |
| <hr/> | |
| 06 | Reduz cafeína nos dias críticos.
Nas mulheres com lentos metabolizadores de cafeína, ela amplifica ansiedade e raiva pré-menstrual.
Substitui por chá verde ou matcha se precisas de cafeína. |
| <hr/> | |
| 07 | Investiga o terreno em vez de tratar só o sintoma.
Análises funcionais: Anti-TPO, ferritina, vitamina D, B12, folato, insulina, HOMA-IR, perfil hormonal.
Anticorpos tiroideus e insulina alta amplificam a raiva. |
-

As recomendações acima são gerais. Não substituem avaliação clínica individual. Antes de iniciar suplementação ou alterar medicação, fala com profissional qualificado.

Os erros mais comuns vêm de boas intenções. Custam tempo, energia e identidade.

05 · ARMADILHAS

O que costuma falhar.

-
- ✗ **"É da idade. Vai passar."** A maioria das mulheres é informada disto. A perimenopausa pode durar 7-10 anos. Não é estratégia esperar.
 - ✗ **Antidepressivos sem investigação hormonal.** Há casos em que ajudam. Mas medicar antes de avaliar tiroide, vitamina D, ferro, insulina e progesterona é tratar o sintoma sem entender o terreno.
 - ✗ **Cortar tudo de uma vez.** Suplementação completa + dieta restritiva + treino intenso ao mesmo tempo. Sobrecarrega cortisol e piora a raiva.
 - ✗ **Dietas muito restritivas em calorias.** Aumentam cortisol, diminuem T3, agravam fadiga e irritabilidade. A perimenopausa precisa de proteína suficiente, não de déficit agressivo.
 - ✗ **Ignorar sono e álcool.** Uma taça de vinho à noite parece relaxar, mas fragmenta sono REM e amplifica a raiva no dia seguinte.
 - ✗ **Comparar-se com mulheres de 30.** A bioquímica mudou. As estratégias de sono, treino, comida e cafeína têm de mudar com ela.
-

Se reconheces o teu caso aqui.

A perimenopausa não é um problema a resolver. É um terreno a trabalhar. As estratégias acima começam a estabilizar — mas a verdadeira mudança vem quando se percebe o teu caso específico: as tuas hormonas, o teu ciclo, os teus marcadores funcionais.

Se queres ir além das ações gerais e perceber o teu terreno em profundidade, a avaliação biofuncional é por onde começamos.

AVALIAÇÃO BIOFUNCIONAL

Análises completas. Entrevista profunda. Plano individualizado.

Marcadores que a TSH normal não mostra. Hormonas, micronutrientes, metabolismo, auto-imunidade. Plano integrado com medicação convencional, se aplicável. Reavaliação em 3 e 6 meses.

→ CATARINAVEIGA.COM / AVALIACAO

A raiva da perimenopausa não é mau feitio. É química, é hormonal, é real. E responde quando se trabalha o terreno.

Não és tu. São as tuas hormonas.